

Схема 4. Стационарный этап: план по суткам

типовой сценарий планового лапароскопического вмешательства без осложнений

Сутки –1	Сутки 0	Сутки 1	Сутки 2	Сутки 3–4
Госпитализация	Операция	Ранняя активизация	Расширение режима	Выписка
— Осмотр хирурга и анестезиолога — Контроль результатов обследования — Подбор компрессионного трикотажа — Начало профилактики ВТЭО — Подписание согласий — Лёгкий ужин, далее голод	— Антибиотикопрофилактика за 30–60 минут — Лапароскопический доступ — Длительность 60–150 минут — Ранняя экстубация — Активизация через 4–6 часов — Обезболивание с минимизацией опиоидов	— Подъём и ходьба по палате — Вода малыми глотками — Контроль пульса, температуры, диуреза — Тест на герметичность по показаниям — Дыхательная гимнастика — Продолжение тромбопрофилактики	— Прозрачные жидкости по 30 мл каждые 15 минут — Удаление дренажа, если он установлен — Контроль общего анализа крови и СРБ — Занятие с диетологом — Отмена инфузионной терапии — ЛФК	— Осмотр хирурга и куратора — Письменные рекомендации по питанию — Назначение витаминов и ИПП — Тромбопрофилактика на 2–4 недели — Дата первого визита и контакты — Листок нетрудоспособности

Сквозные элементы протокола ускоренного восстановления (ERAS):

отказ от длительного голодания и рутинной подготовки кишечника · углеводная нагрузка за 2 часа до операции · нормотермия и целевая инфузионная терапия · мультимодальная анальгезия · профилактика тошноты и рвоты · отказ от рутинных дренажей и назогастрального зонда · активизация в день операции · раннее начало питья

Тревожные признаки, требующие немедленного обращения после выписки:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| — стойкая тахикардия выше 120 в минуту | — лихорадка выше 38 °C |
| — нарастающая боль в животе или в левом надплечье | — невозможность пить более 12 часов |
| — многократная рвота | — одышка, боль в грудной клетке |
| — чёрный стул или рвота с кровью | — покраснение и отделяемое из раны |

Единый телефон дежурного хирурга и координатора выдаётся пациенту на руки при выписке